EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 95432
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-23 09:20:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DANIEL OCTAVIO SAN MARTIN ACEVEDO			RUN	: 7.283.914-5
F.Nac	: 05-12-1954	Edad	: 69 AÑOS, 10 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BRASIL NRO 450 DEPTO 6			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 997317516		
Fecha Ingreso	: 2024-10-19	Fecha Egreso	: 2024-10-23 09:20:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Hiperplasia prostática
2. AKI postrenal resuelta
3. Hernia inguinal izq no complic + Hidrocele
4. Antec: ACV secuelar, HTA, hipotiroidismo---I/Qx Hidrocefalia ?

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con cuadro que inicia el 15/10 cuando consulta por disminución de volumen urinario con imposibilidad para la micción, es evaluado en urgencias, colocan SF , toman exámenes y egresan con tratamiento medico sin sonda, es traído nuevamente el 17/10 en la noche por persistencia del cuadro, asociándose a vómitos de contenido de alimentos descritos como oscuros sin sangre ni olor fétido, seguidamente episodio de cianosis generalizada y rigidez sin relajación de esfínteres ni posterior cuadro confusional, que se interpreta con escalofríos.
Se toman controles en urgencias de TAC de cerebro : sin lesiones agudas, con múltiples areas de isquemias antiguas infra como supratentoriales.
Tac de torax: Sin signos infecciosos, derrame pleural bilateral leve.
PieloTAC: examen negativo para nefrourolitiasis, posibles quistes parapielicos bilaterales. hernia inguinal izq sin signos de complicación.
Laboratorios de ingreso creat 3.70 control 1.10 PCR ingreso 84 control 224.5 uremia 72 ELP 146/3.80/117
Se recibe en sala en condiciones clinicas estables, impreiona en su basal con diagnostico de infección urinaria, se completa estudio con eco prostática que informa prostata aumentada de tamaño e hidrocele sin signos de complicación.
Recibe 5 días de ceftriaxona con evolución favorable, sin fiebre, mejoría de función renal, por lo que se decide continuar con antibioticoterapia en hospitalización domiciliaria.

PLAN DE MANEJO:

Ic a urología

INDICACIONES AL ALTA

1. Cuidados de sonda foley, evaluar retiro de sonda foley en 15 días por su cesfam, de persistir con retención debe colocarse a permanencia
2. Medicación crónica de forma habitual.
3. Ceftriaxona 2 gr ev 5/7

4. Paracetamol 500mg 2 c 8hrs x 3d.
5. Tamsulosina 0,4mg 1 c dia por 30 días.

EXÁMENES Y RESULTADOS

Urocultivo: Proteus mirabilis y klebsiella pneumoniae sensibles a ceftriaxona.
Crea 1,00.

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO